E-BOOK

SUPORTE MEDICAMENTOSO

EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL

Guia prático de analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos e ansiolíticos para consulta clínica

2ª EDIÇÃO

FOUSP · 2026

AUTORES

Alexandre Frizzarini Sacoman · Barnabé Fona Gomes · Bruno Alvarez Quinta Reis · Levi Saulo Rodrigues de Jesus · Lucas Daniel Lago Lopes Cunha · Lucas Maia · Lucas Morita · Mayra Mobile · Nicole Fornari Sigolo · Pedro Americo Felizardo dos Santos · Sandra Regina Guimaraes · Talita Lopes · Vinícius Rocha

SUPERVISÃO E REVISÃO

Natacha Kalline de Oliveira · Mariana Aparecida Brozoski · Matheus Dantas de Araujo Barretto · Natália Pieretti Bueno · Ricardo Grillo

ANALGÉSICOS
Lucas Maia, Lucas Morita

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS
Bruno Alvarez Quinta Reis, Barnabé Fona Gomes

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS
Mayra Mobile, Sandra Regina Guimaraes

ANTIBIÓTICOS
Alexandre Frizzarini Sacoman, Levi Saulo Rodrigues de Jesus, Nicole Fornari Sigolo, Talita Lopes, Vinícius Rocha

ANSIOLÍTICOS
Lucas Daniel Lago Lopes Cunha, Pedro Americo Felizardo dos Santos

EDIÇÃO BASE (2021)
Isabelle Müller, Luiza Bastos Nozari, Matheus Dantas de Araújo Barretto, Melissa Batoki Chad, Natália Pieretti Bueno, Sandro Bornelli Moreira, Vinicius Paes de Assis Santos

SUPERVISÃO E REVISÃO
Profa. Dra. Maria da Graça Naclério-Homem

Catalogação da Publicação

Suporte medicamentoso em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. 2. ed. São Paulo: FOUSP, 2026. E-book.

1. Analgésicos. 2. Anti-inflamatórios não esteroidais. 3. Anti-inflamatórios esteroidais. 4. Antibióticos. 5. Ansiolíticos.

INTRODUÇÃO

A execução de um ato operatório não deve ser aleatória, mas seguir os princípios fundamentais da cirurgia que garantem o sucesso do procedimento. O suporte farmacológico perioperatório visa otimizar o pós-operatório pelo controle da dor e do edema e pela prevenção de processos infecciosos. Nesta edição, cada classe farmacológica é revisitada à luz das evidências atuais.

Este guia é um instrumento de orientação, sem restrição às demais medicações. O cirurgião-dentista, de acordo com a Lei 5.081/1966, pode prescrever e aplicar todas as especialidades farmacêuticas, de uso interno e externo, indicadas em sua área de atuação. Doses referem-se a adultos saudáveis, salvo indicação.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 3

ANALGÉSICOS 5

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS 11

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS 14

ANTIBIÓTICOS 18

ANSIOLÍTICOS 39

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 48

ANALGÉSICOS

Diretrizes Clínicas para Controle da Dor Pós-Operatória em Adultos

1 REGIMES ANALGÉSICOS EM ODONTOLOGIA

PREEMPTIVA

Administração de medicação antes do estímulo nocivo. Visa prevenir a sensibilização central e diminuir a intensidade da dor.

PREVENTIVA

Administração contínua do fármaco para bloquear os mediadores inflamatórios durante todo o período em que a nocicepção está ativa.

PERIOPERATÓRIA

Combinação estratégica de condutas antes, durante e após a cirurgia.

2 CLASSIFICAÇÃO DOS FÁRMACOS ANALGÉSICOS

DEPRESSORES SNC

- Dipirona. Atua no SNC e periferia. Analgésico e antipirético eficaz.

INIBIDORES COX

- Ibuprofeno | Cetorolaco. Ação anti-inflamatória e analgésica periférica por inibição da COX.

OPIOIDES

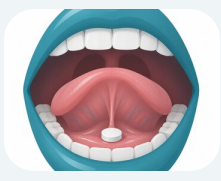
- Codeína | Tramadol. Agonistas receptores mu no SNC. Para dor moderada a severa refratária.

CORTICOIDES

- Dexametasona. Inibe fosfolipase A2, prevenindo edema e hiperalgesia intensa.

ANALGÉSICOS

3 DOSAGENS USUAIS DE MANUTENÇÃO PARA ADULTOS

FÁRMACO	DOSE USUAL (ADULTOS)	INTERVALO / OBSERVAÇÕES CLÍNICAS
 Dipirona	500 mg a 1 g VO	A cada 4h a 6h (Dose máx.: 4 g/dia)
 Paracetamol	500 mg a 750 mg VO	A cada 6h (Dose máx.: 3 g/dia)
 Ibuprofeno	200 mg a 600 mg VO	A cada 6h a 8h (Dose máx.: 2400 mg/dia)
 Naproxeno	250 mg a 500 mg VO	A cada 12h (Dose máx.: 1000 mg/dia)
 Cetorolaco SL	10 mg Sublingual	A cada 6h a 8h (Dose máx.: 40 mg/dia | uso máx. 5 dias)
 Paracetamol + Codeína	500 mg / 30 mg VO	A cada 6h (Dose máx.: 4 comp/dia)
 Tramadol	50 mg a 100 mg VO	A cada 6h a 8h (Dose máx.: 400 mg/dia)
 Dexametasona	4 mg a 8 mg VO	Dose única pré-operatória (1 hora antes)

4 SEGURANÇA & CONTRAINDICAÇÕES ESSENCIAIS

ANALGÉSICOS SIMPLES

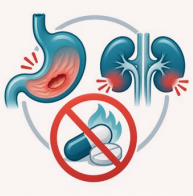


Paracetamol: Risco hepático (>3g/dia). Cuidado em hepatopatas/etilistas.



Dipirona: Segura na maioria dos pacientes. Contraindicada em discrasias sanguíneas, gestantes (1º e 3º trimestres).

AINES E OPIOIDES



AINEs: Contraindicados em úlcera gástrica ativa, insuficiência renal crônica avançada, 3º trimestre gestacional e asma.



Opioides: Usar por 2 a 3 dias em dores refratárias.

FLUXOGRAMA DECISÓRIO DE MANEJO DA DOR PÓS-OPERATÓRIA

Condutas recomendadas por nível de intensidade e complexidade cirúrgica

PACIENTE COM DOR

Avaliar intensidade da dor e sinais clínicos

Qual é o nível de dor?

ANALGÉSICOS

NÍVEL 1: LEVE

Dor que permite atividades habituais.

- Dipirona 500 mg, Paracetamol 750 mg ou Ibuprofeno 300 mg

É pós-operatório de exodontia simples?

✓ Sim

- Dipirona 500 mg 1 g de 6/6h (ou 4/4h) VO
- Paracetamol 500-750 mg de 6/6h
- OU Ibuprofeno 200-400 mg de 6/6h a 8/8h

Duração: 1 a 2 dias

× Não

Reavaliar e reclassificar o nível de dor.

Reavaliar dor e resposta ao tratamento.
Se persistir dor ou piora → reclassificar.

NÍVEL 2: MODERADA

Dor que interfere em algumas atividades.

MONOTERAPIA:

- Ibuprofeno 400-600 mg, Cetorolaco SL 10 mg ou Naproxeno 550 mg

MULTIMODAL:

- Ibuprofeno 300 mg de 6/6h + Dipirona 1 g de 6/6h OU Paracetamol 750 mg de 6/6h

É pós-operatório de exodontias múltiplas/complexas?

✓ Sim

- Ibuprofeno 400-600 mg de 6/6h a 8/8h (3 dias)
- OU Cetorolaco 10 mg SL de 6/6h a 8/8h
- OU Naproxeno 550 mg 12/12h (3 dias)

× Não

Reavaliar e reclassificar o nível de dor.

Reavaliar dor e resposta ao tratamento.
Se persistir dor ou piora → reclassificar.

ANALGÉSICOS

NÍVEL 3: INTENSA

Dor que impede atividades e/ou em repouso.

- Ibuprofeno 400 mg de 6/6h + Dipirona 1 g de 6/6h OU Paracetamol 750 mg de 6/6h (esquema fixo associado)
- Cetorolaco ou Ibuprofeno 600 mg
- Resgate com Paracetamol+Codeína ou Tramadol.

É dor intensa ou refratária?

✓ Sim

- Cetorolaco 10 mg SL (6/6h-8/8h) OU Ibuprofeno 600 mg (6/6h por 3-4 dias).
- Pré-Op: Dexametasona 4-8 mg + Manutenção (Ibuprofeno 400 mg + Dipirona 1 g OU Paracetamol 750 mg) de 6/6h (3-4 dias).
- Se dor intensa (dor refratária): Opioide: Paracetamol + Codeína 30 mg 6/6h (até 3 dias) ou Tramadol 50 mg 6/6h (até 3 dias).

× Não

Reavaliar e reclassificar o nível de dor.

Reavaliar dor e resposta ao tratamento.
Se persistir dor ou piora → reclassificar.

Em todos os níveis: monitorar sinais de alerta, avaliar contraindicações, ajustar dose conforme paciente e tempo de uso.

5 CONDUTAS CLÍNICAS DETALHADAS POR NÍVEL DE DOR

NÍVEL 1 (LEVE) – EXODONTIAS SIMPLES



Monoterapia: Dipirona 500 mg-1 g de 6/6h (ou 4/4h) OU Paracetamol 500-750 mg de 6/6h OU Ibuprofeno 200-400 mg de 6/6h a 8/8h (Duração: 1 a 2 dias).

NÍVEL 2 (MODERADA) — EXODONTIAS MÚLTIPLAS/COMPLEXAS



- Opção 1 (Monoterapia): Ibuprofeno 400-600 mg de 6/6h a 8/8h (3 dias) OU Cetorolaco 10 mg SL de 6/6h a 8/8h OU Naproxeno 550 mg 12/12h (3 dias).
- Opção 2 (Multimodal): Pré-Op (avaliar a necessidade): Dexametasona 4 mg (60 min antes) + Manutenção (Ibuprofeno 300 mg 6/6h + Dipirona 1 g 6/6h ou Paracetamol 750 mg 6/6h)

NÍVEL 3 (INTENSA / REFRATÁRIA) — SISOS INCLUSOS, OSTEOTOMIAS



- Opção 1 (Monoterapia): Cetorolaco 10 mg SL (6/6h-8/8h) OU Ibuprofeno 600 mg (6/6h por 3-4 dias).
- Opção 2 (Multimodal): Pré-Op Dexametasona 4-8 mg + Manutenção (Ibuprofeno 400 mg + Dipirona 1 g OU paracetamol 750 mg) de 6/6h (3-4 dias)
- Se dor intensa (Dor refratária) ➔ Opioide: Paracetamol + Codeína 30 mg 6/6h (até 3 dias) ou Tramadol 50 mg 6/6h (até 3 dias)

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINES)

Alívio da dor, redução da inflamação e da febre

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS



Os AINEs podem auxiliar no controle da dor, do edema e da limitação da abertura bucal no período pós-operatório.

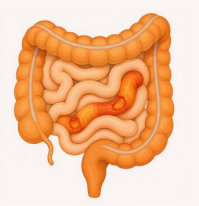


A intensidade da inflamação após o procedimento depende de fatores como duração da cirurgia, extensão da área operada e grau de manipulação dos tecidos.

CONTRAINDICAÇÃO RELATIVA



Distúrbios de coagulação



Doença de Crohn



HAS (hipertensão arterial sistêmica)



Diabetes mellitus



Asma

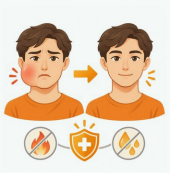


Hepatopatias

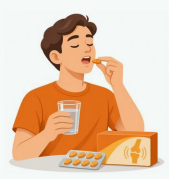
INDICAÇÃO



Pacientes saudáveis



Controle do processo inflamatório



Analgesia pós-cirúrgica

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS

2 ESTRATÉGIAS DE PRESCRIÇÃO

AINES NÃO SELETIVOS E SELETIVOS



- São ótimos analgésicos, como ibuprofeno e nimesulida.
- Exemplos: Ibuprofeno; Nimesulida; Diclofenaco; Cetoprofeno

AINES ESPECÍFICOS (COXIBES E ETORICOXIBES)



- Não devem ser prescritos sem rigorosa anamnese, pois podem estar associados a maior risco cardiovascular em algumas situações.
- Exemplos: Celecoxibe; Etoricoxibe
- Avaliar sempre fatores de risco cardiovascular e gastrointestinal.

LEMBRE-SE



- Respeite as contraindicações.
- Avalie o perfil do paciente.
- Use a menor dose eficaz pelo menor tempo.
- Evite o uso indiscriminado, principalmente dos coxibes.

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS

3 DOSES, INTERVALOS E CONTEXTOS DE USO

FÁRMACO	DOSE	INTERVALO	PROCEDIMENTO / CONTEXTO
 Diclofenaco	50 mg	8/8h	Exodontia de dentes inclusos.
 Cetoprofeno	50 mg 100 mg	8/8h 12/12h	Exodontia de dentes inclusos. Cirurgia ortognática: por via endovenosa no pós-operatório imediato e uso oral após alta hospitalar.
 Ibuprofeno	300 mg a 600 mg	8/8h ou 12/12h	Exodontia de dentes inclusos. Cirurgia Ortognática. Efeito analgésico associado.
 Nimesulida	100 mg	12/12h	Exodontia de dentes inclusos. Cirurgia Ortognática.
 Cetorolaco	10 mg	8/8h	Exodontia de dentes inclusos. Cirurgia Ortognática. Efeito analgésico associado.

IMPORTANTE!



- Doses e intervalos devem ser individualizados conforme paciente, indicação, função renal/hepática, risco gastrointestinal e cardiovascular, contraindicações e bula/protocolo institucional.
- Usar a menor dose eficaz pelo menor tempo.

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS

Corticoesteroides no manejo pré e pós-operatório em cirurgia odontológica

OBJETIVO DO USO

Controlar a inflamação pós-operatória com a menor exposição sistêmica possível, sem substituir analgésicos ou medidas locais.

1 POR QUE USAR?

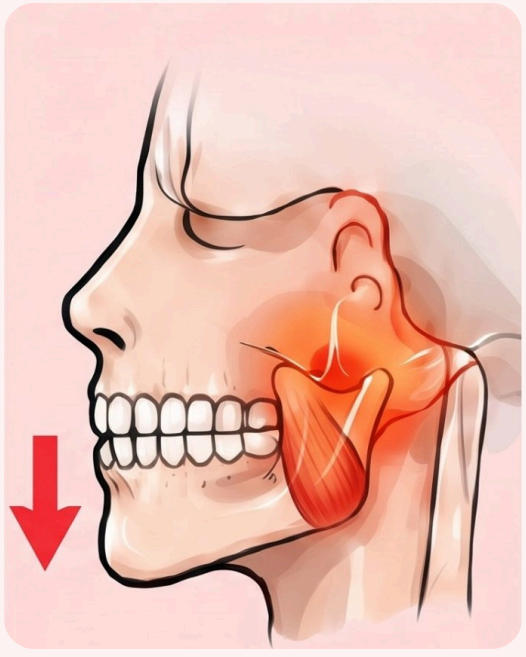
Eles minimizam sinais como:



Edema

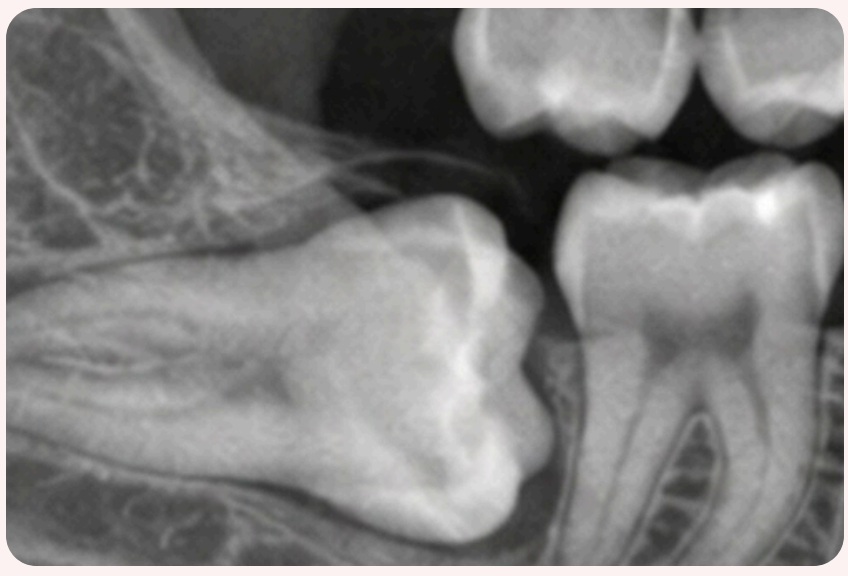


Dor

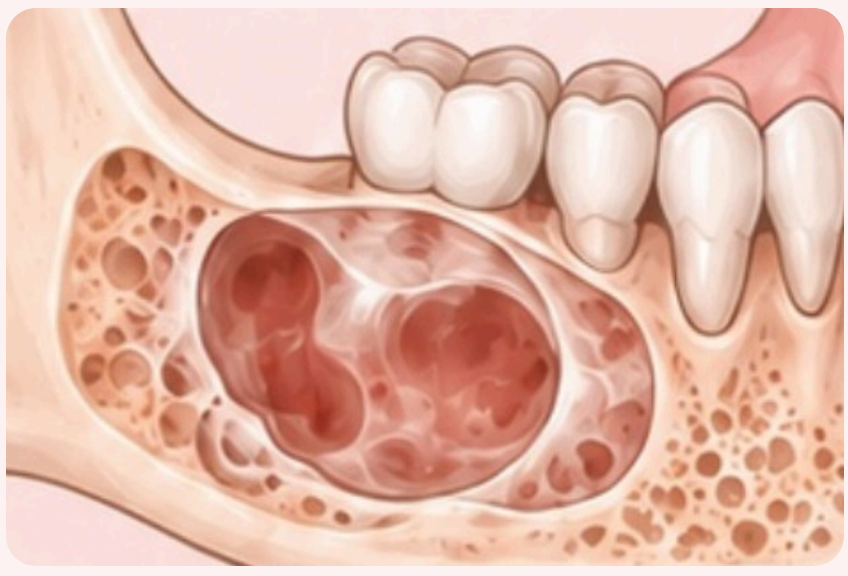


Trismo

2 QUANDO USAR?



Dentes não irrompidos ou impactados



Cirurgias longas, invasivas ou com necessidade de osteotomia

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS

3 QUAIS MEDICAÇÕES E DOSES?

MEDICAÇÃO	DOSE PRÉ-OPERATÓRIA (DOSE ÚNICA)	PRINCIPAIS INDICAÇÕES
Dexametasona	8 mg 1 hora antes da cirurgia	• Redução de edema • Controle da dor • Redução de trismo

VANTAGEM DA DOSE ÚNICA PRÉ-OPERATÓRIA

- A utilização de dose única reduz o pico da inflamação, sem a necessidade de regimes prolongados, diminuindo o risco de repercussões sistêmicas.

4 QUANDO NÃO USAR?

Diabetes
não controlada

Hipertensão
não controlada

Hepatopatias

Infecções
ativas não tratadas

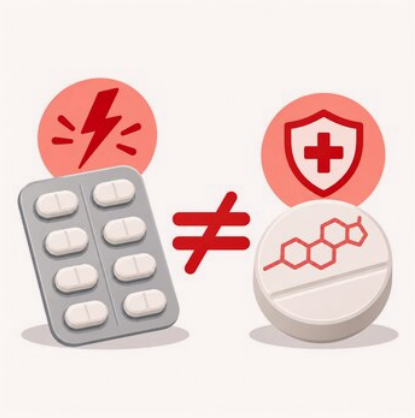
Hipersensibilidade
aos corticoides

Uso crônico
de corticoides

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS

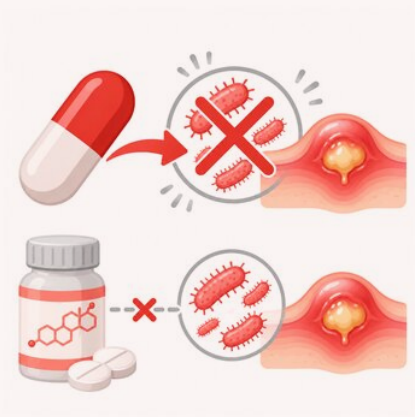
5 O QUE OS CORTICOIDES NÃO SUBSTITUEM?

ANALGESIA CONVENCIONAL



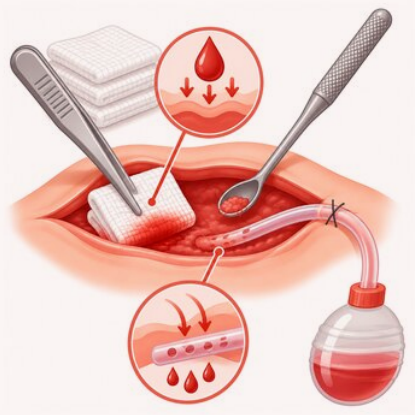
Corticoides não são analgésicos primários. O controle adequado da dor exige analgésicos e/ou AINEs, conforme a necessidade do paciente.

ANTIBIÓTICOS



Não têm ação antimicrobiana e podem mascarar sinais de infecção na presença de um foco purulento ativo.

PROCEDIMENTOS LOCAIS



Não substituem hemostasia, desbridamento cirúrgico e/ou drenagem quando indicados.

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS

RESUMO PRÁTICO DE CONSULTÓRIO

1 · ANAMNESE E AVALIAÇÃO DO QUADRO SISTÊMICO



Investigar histórico de diabetes (risco de elevação glicêmica), hipertensão arterial (aferir a PA) e hepatopatias antes de prescrever.

2 · CHECAGEM DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS



Avaliar o uso concomitante de AINEs (aumento do risco gastrointestinal), anticoagulantes (ex.: varfarina) e macrolídeos ou azólicos.

3 · ORIENTAÇÃO E REGISTRO EM PRONTUÁRIO



Explicar ao paciente o objetivo do medicamento (foco no controle do edema) e registrar a justificativa clínica e posologia no prontuário acadêmico.

ANTIBIÓTICOS

APRESENTAÇÃO E RACIOCÍNIO CLÍNICO

A prescrição de medicamentos faz parte da prática do cirurgião-dentista e exige conhecimento sobre indicação, escolha do fármaco, dose, via de administração, duração, contraindicações, interações e possíveis eventos adversos.

Na Odontologia, os antibióticos são importantes no tratamento de determinadas infecções e em situações específicas de profilaxia. Entretanto, uma cirurgia ou infecção odontogênica não significa, por si só, indicação de antibiótico. Muitas situações são resolvidas principalmente pelo controle da causa, como drenagem, remoção do foco infeccioso, tratamento endodôntico ou exodontia.

Este material foi elaborado como instrumento de estudo e apoio ao raciocínio clínico dos estudantes de graduação em Odontologia, com foco na cirurgia oral ambulatorial e nos procedimentos odontológicos de pequeno porte.

Antes da prescrição, avalie:

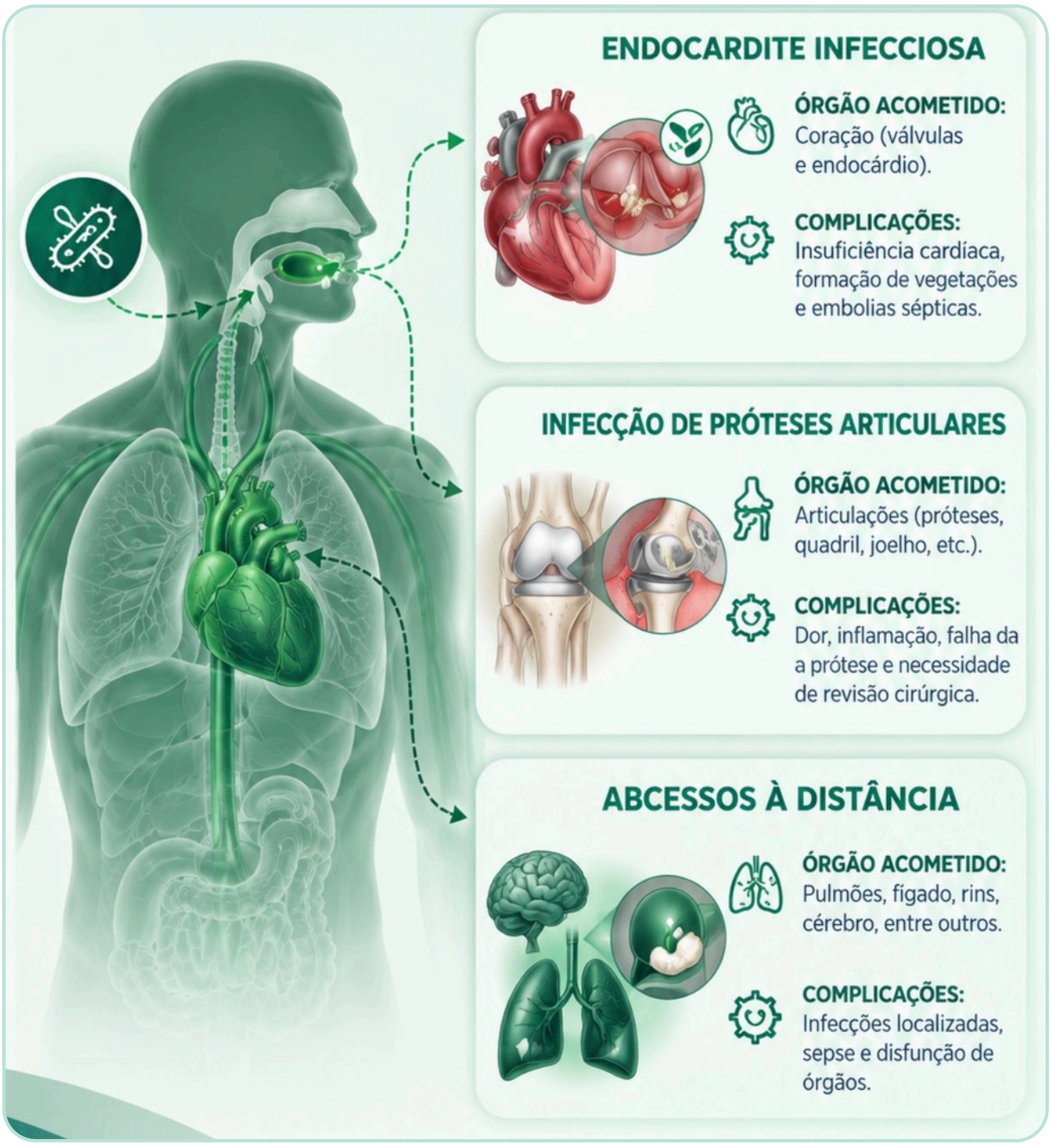
- Há indicação de antibiótico?
- Existe indicação de profilaxia?
- Qual medicamento, dose e via devem ser utilizados?
- Há alergias ou condições que modifiquem a escolha?
- Qual a duração do tratamento?
- Existem sinais de gravidade que indiquem encaminhamento?

Este guia apoia o raciocínio clínico, mas não substitui a avaliação individual, a supervisão docente, a consulta à bula ou a verificação das diretrizes vigentes.

ANTIBIÓTICOS

TIPOS DE INFECÇÕES À DISTÂNCIA E ÓRGÃOS ACOMETIDOS (ORIGEM ORAL)

As manifestações dependem diretamente das condições sistêmicas prévias do paciente.

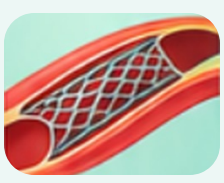


1 CARDIOPATIAS DE ALTO RISCO

Apenas esses pacientes têm indicação de profilaxia antibiótica antes de procedimentos odontológicos de risco. Veja cada condição.

CONDIÇÃO CARDÍACA	PROFILAXIA ANTES DO PROCEDIMENTO?	OBSERVAÇÃO
 Prótese valvar cardíaca (mecânica ou biológica), incl. prótese transcateter e homoenxerto	SIM	Grupo de maior risco.
 Material protético usado no reparo valvar	SIM	—
 Endocardite infecciosa prévia	SIM	—
 Cardiopatia congênita não corrigida	SIM	—
 Cardiopatia congênita corrigida com defeito residual (shunt ou regurgitação) no local ou junto ao material/dispositivo protético	SIM	—
 Cardiopatia congênita corrigida com material/dispositivo protético – primeiros 6 meses após o procedimento	SIM	Após 6 meses e sem defeito residual, deixa de indicar.
 Transplante cardíaco com valvopatia (regurgitação por valva estruturalmente anormal)	SIM	—

CARDIOPATIAS DE ALTO RISCO (CONT.)

CONDIÇÃO CARDÍACA	PROFILAXIA ANTES DO PROCEDIMENTO?	OBSERVAÇÃO
 Cardiopatia reumática em alto contexto de penicilina	AVALIAR	Decisão do cardiologista. Se indicada, preferir Azitromicina ou Claritromicina.
 Valvopatia nativa (p. ex., prolapso mitral, estenose aórtica), CIV/CLV/PCA sem defeito residual, doença coronariana	NÃO	Fora dos grupos de maior risco.
 Revascularização (angioplastia, ponte), stent, marca-passo, desfibrilador	NÃO	Não recomendada de rotina; a cardiopatia asuida a condição hemodinâmica.
 Febre reumática sem lesão valvar	NÃO	—

2 PROFILAXIA MEDICAMENTOSA PARA DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

Indicações, esquemas e duração do tratamento

PROCEDIMENTO / QUADRO CLÍNICO	NECESSITA MEDICAMENTO?	1ª ESCOLHA (DOSE/POSOLOGIA)	ALTERNATIVA PARA ALÉRGICOS	DURAÇÃO DO TRATAMENTO
 Frenectomia labial ou lingual, excisão de mucocele, fibroma ou pequenas cirurgias de tecido mole	NÃO	—	—	—
 Apicectomia / cirurgia perirradicular	AVALIAR	Amoxicilina 1 g VO, 1 h antes	Clindamicina 600 mg VO, 1 h antes	Dose única, sem curso pós-operatório
 Cirurgias periodontais	AVALIAR	Amoxicilina 1 g VO, 1 h antes	Clindamicina 600 mg VO, 1 h antes	Dose única, sem curso pós-operatório
 Implantes	AVALIAR	Amoxicilina 2 g VO, 1 h antes	Clindamicina 600 mg VO, 1 h antes	Avaliar conforme procedimento, pode incluir curso pós-operatório

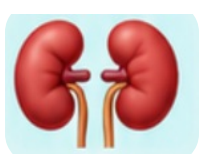
PONTOS-CHAVE

- A profilaxia medicamentosa deve ser individualizada.
- A decisão deve considerar o quadro clínico.
- A profilaxia não substitui medidas básicas de biossegurança.
- O uso indiscriminado de medicamentos deve ser evitado.

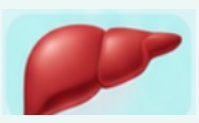
3 PROFILAXIA MEDICAMENTOSA PARA CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Profilaxia à distância e cautelas

Indica-se a antecipação do uso de medicamento em condições que podem levar à infecção, de alto risco e baixa frequência.

CONDIÇÃO / QUADRO CLÍNICO	PROFILAXIA?	CONDUTA E OBSERVAÇÕES
 Prótese articular (quadril ou joelho)	AVALIAR	Não é rotina. Considerar apenas em pacientes com imunocomprometimento, histórico prévio de infecção da prótese, procedimentos de maior risco, ou conforme orientação do ortopedista.
 Prótese valvar e doença cardíaca congênita	NÃO	Não é rotina.
 Diabetes	NÃO	Não é rotina, exceto quando houver descontrole glicêmico ou condições sistêmicas associadas. Manter controle adequado da doença.
 Doença renal crônica / diálise	AVALIAR	Considerar em pacientes imunossuprimidos, comorbidades associadas ou conforme a gravidade da condição sistêmica.
 Imunossuprimidos (quimioterapia, radioterapia, uso de imunossupressores)	AVALIAR	Maior risco de infecção. Avaliar tipo de imunossupressão, tempo de tratamento e quadro clínico. Considerar profilaxia conforme protocolo institucional.
 HIV	NÃO	Não é rotina, desde que o paciente esteja em acompanhamento e com carga viral controlada. Em imunossupressão avançada, avaliar individualmente.
 Gestante	AVALIAR	Seguir diretrizes específicas para cada trimestre e condição clínica. Evitar fármacos contraindicados e avaliar risco-benefício.

PROFILAXIA MEDICAMENTOSA PARA CONDIÇÕES ESPECÍFICAS (CONT.)

CONDIÇÃO / QUADRO CLÍNICO	PROFILAXIA?	CONDUTA E OBSERVAÇÕES
 Hepatopatia	AVALIAR	Avaliar metabolismo hepático dos fármacos e ajustar dose, quando necessário.
 Insuficiência cardíaca descompensada, endocardite	AVALIAR	Avaliar condição sistêmica e risco de infecção. Profilaxia conforme protocolo médico.
 Uso de bifosfonatos, denosumabe ou outras terapias antirressortivas	AVALIAR	Maior risco de osteonecrose dos maxilares. Avaliar procedimento, tempo de uso e condição sistêmica.

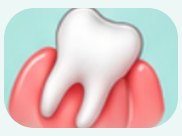
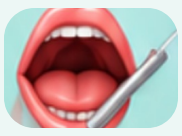
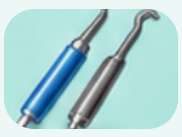
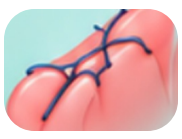
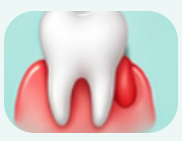
CUIDADOS ESPECIAIS



- Evitar fármacos contraindicados na gestação (ex.: tetraciclinas, fluoroquinolonas).
- Preferir medicamentos com bom perfil de segurança (ex.: amoxicilina, quando indicada).
- Avaliar o trimestre gestacional e o risco-benefício do procedimento.
- Realizar procedimentos eletivos, preferencialmente, no 2º trimestre.
- Manter comunicação com o obstetra e acompanhamento adequado.
- Orientar a paciente sobre sinais de infecção e retorno imediato em caso de intercorrências.

4 PROCEDIMENTOS DE RISCO

Quando a profilaxia de endocardite é necessária

PROCEDIMENTO OU EVENTO	PROFILAXIA AHA?
 Exodontias, dentes inclusos, cirurgias dentoalveolares	SIM
 Apicectomia / cirurgia perirradicular	SIM
 Biópsia de mucosa oral	SIM
 Frenectomia e demais cirurgias gengivais de tecido mole	SIM
 Cirurgias periodontais, raspagem e alisamento, implantes	SIM
 Sutura de laceração intrabucal traumática	AVALIAR
 Anestesia infiltrativa de rotina em tecido não infectado	NÃO
 Radiografias; colocação ou ajuste de aparelho removível, ortodôntico ou bráquetes	NÃO
 Esfoliação de dente decíduo; sangramento por trauma de lábio ou mucosa oral	NÃO
 Paciente que já toma antibiótico (por outro motivo)	AVALIAR
 Dose esquecida antes do procedimento	AVALIAR

5 PROTOCOLOS AHA DE PROFILAXIA

Farmacologia

Prevenção de endocardite infecciosa em procedimentos odontológicos e cirúrgicos.

DOSE ÚNICA, 30 A 60 **MINUTOS** ANTES DO PROCEDIMENTO.

A dose pediátrica nunca ultrapassa a dose de adulto.

30–60 min antes → Proteção durante o procedimento.

CONDIÇÃO DO PACIENTE	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	MEDICAMENTO	DOSE ADULTO	DOSE PEDIÁTRICA	MOMENTO DA TOMADA
Padrão – sem alergia, aceita via oral	Oral	Amoxicilina (1ª escolha)	2 g	50 mg/kg	Dose única, 30–60 min antes
Sem alergia, não tolera via oral	IM ou IV	Ampicilina (1ª escolha parenteral)	2 g	50 mg/kg	Dose única, 30–60 min antes
Sem alergia, não tolera via oral (2ª escolha)	IM ou IV	Cefazolina ou ceftriaxona	1 g	50 mg/kg	Dose única, 30–60 min antes
Alergia às penicilinas, via oral (2ª escolha)	Oral	Cefalexina	2 g	50 mg/kg	Dose única, 30–60 min antes
Alergia às penicilinas, via oral (alternativa)	Oral	Azitromicina ou claritromicina	500 mg	≤ 45 kg: 2,2 mg/kg > 45 kg: 1000 mg	Dose única, 30–60 min antes
Alergia às penicilinas, via oral (alternativa)	Oral	Doxiciclina	100 mg	—	Dose única, 30–60 min antes

ANTIBIÓTICOS

CONDIÇÃO DO PACIENTE	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	MEDICAMENTO	DOSE ADULTO	DOSE PEDIÁTRICA	MOMENTO DA TOMADA
Alergia às penicilinas, sem anafilaxia, angioedema ou urticária, e sem via oral	IM ou IV	Cefazolina ou ceftriaxona	1 g	50 mg/kg	Dose única, 30–60 min antes
Alergia grave (anafilaxia, angioedema, urticária) e sem via oral	IM ou IV	Sem esquema padronizado na AHA 2021	—	—	Discutir com cardiologista ou infectologista, considerar avaliação individual.
Esquema antigo (AHA 2007 e livro): alérgico, oral ou IM/IV	Oral, IM ou IV	Clindamicina – não recomendada desde 2021	600 mg	20 mg/kg	30–60 min antes. Considerar apenas se nenhuma outra opção for possível, com decisão individual.

Vias de administração



ORAL
Via mais cômoda e preferida.



IM
Injeção intramuscular.



IV
Infusão endovenosa.

Exemplos de doses



Adulto
2 g (amoxicilina)



Pediátrica
50 mg/kg (para amoxicilina)

Procedimentos odontológicos e cirúrgicos contemplados



Limpeza dental e raspagem



Exodontia



Implante



Cirurgias maxilofaciais

6 ALERGIA ÀS PENICILINAS

O que usar, o que evitar e reação cruzada

História de alergia: Sintomas; Tempo de início; Medicamento; Gravidade

PERFIL DO PACIENTE	O QUE USAR	O QUE EVITAR	JUSTIFICATIVA
 **"Alergia" vaga: náusea, vômito, diarreia, tontura, ansiedade ou sudorese ligadas ao procedimento**	Investigar a história, sem sinais de hipersensibilidade, manter a amoxicilina.	Trocar por outro antibiótico sem investigar.	Esses sintomas não são alergia. A reação alérgica à penicilina ocorre em cerca de 2% por tratamento; anafilaxia é rara (~1 em 10 mil no Brasil) e mais frequente por via injetável [L].
 **Reação leve e tardia, sem choque, anafilaxia, angioedema ou urticária**	Cefalexina 2 g (profilaxia) ou cefalosporina oral 1ª/2ª geração; ou macrolídeo.	Penicilinas.	A AHA aceita cefalosporina quando não houver reação imediata [AHA 2021].
 **Reação imediata: anafilaxia, angioedema, urticária, broncoespasmo**	Profilaxia: azitromicina ou claritromicina 500 mg adulto; alternativa: doxiciclina 100 mg. Tratamento: claritromicina ou azitromicina; clindamicina com critério [L].	Todas as penicilinas e todas as cefalosporinas (cefalexina, cefalosporina, ceftriaxona).	Risco de reação cruzada. Cefalexina, cefadroxila e cefaclor têm cadeia lateral parecida com a da amoxicilina, aumentando o risco [E].
 **Alérgico + QT longo, insuficiência cardíaca descompensada ou bradiarritmia**	Doxiciclina (profilaxia); conversar com o cardiologista.	Azitromicina e claritromicina.	Alerta do FDA: risco de arritmia grave com azitromicina [L].

ANTIBIÓTICOS

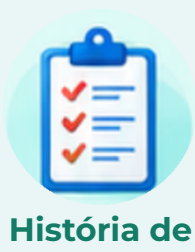
PERFIL DO PACIENTE	O QUE USAR	O QUE EVITAR	JUSTIFICATIVA
 **Alérgico + uso de varfarina, estatinas, bloqueador de canal de cálcio, carbamazepina, midazolam**	Azitromicina (sem interação relevante descrita).	Claritromicina e eritromicina.	Inibem enzimas hepáticas (CYP3A4) e elevam o nível desses fármacos [L].
 **Alérgico + gestante**	Azitromicina, estearato de eritromicina, clindamicina.	Doxiciclina/tetraciclinas; estolato de eritromicina.	Tetraciclinas e estolato são contraindicados em toda a gestação [L].



Náusea, diarreia e ansiedade durante o atendimento não são alergia.

A maioria dos pacientes rotulados como **alérgicos** pode receber **penicilina** com segurança.

IMPORTANTE! | Na reação imediata (anafilaxia, angioedema, urticária), evite todas as penicilinas e todas as cefalosporinas. Adrenalina é o tratamento de escolha na anafilaxia!



História de alergia e avaliação clínica
Evite confusões diagnósticas.



Medicações alternativas
Escolha segura quando indicado.



Risco de QT longo
Atenção a arritmias e interações.



Interações medicamentosas
Evite elevação de níveis séricos.



Gestação
Evite tetraciclinas e estolato.



Reação imediata
Evite todas as penicilinas e cefalosporinas.

7 CIRURGIA ORAL

Exodontias e cirurgias dentoalveolares

Assepsia rigorosa e técnica cirúrgica adequada têm maior importância do que o antibiótico. Veja quando indicar:

PROCEDIMENTO / QUADRO CLÍNICO	NECESSITA ANTIBIÓTICO?	1ª ESCOLHA (DOSE/POSOLOGIA)	ALTERNATIVA PARA ALÉRGICOS	DURAÇÃO DO TRATAMENTO	OBSERVAÇÕES CLÍNICAS
 Exodontia simples	NÃO	—	—	—	O procedimento tem risco muito reduzido de infecção. Antibioticoterapia inadequada contribui para a resistência e a falha terapêutica.
 Exodontia ou cirurgia dentoalveolar potencialmente contaminada	SIM	Amoxicilina 2 g VO, 30–60 min antes	Clindamicina 2 g ou azitromicina 500 mg VO, 1 h antes [1]	Dose única	Devem ser indicados apenas para procedimentos com indicação cirúrgica.
 Terceiros molares inclusos	AVALIAR	Se indicado: amoxicilina 1–2 g VO, dose única, 1 h antes [1]	Se indicado: clindamicina 300 mg VO, 1 h antes ou 600 mg em cirurgia prolongada [1]	Dose única ou por manutenção	Favorecem o risco cirúrgico (decorrência de espaços, maior tempo operatório). Risco de infecção pós-operatória aumenta com a dificuldade técnica e a presença de tecido ósseo impactado.

CIRURGIA ORAL (CONT.)

PROCEDIMENTO / QUADRO CLÍNICO	NECESSITA ANTIBIÓTICO?	1ª ESCOLHA (DOSE/POSOLOGIA)	ALTERNATIVA PARA ALÉRGICOS	DURAÇÃO DO TRATAMENTO	OBSERVAÇÕES CLÍNICAS
 **Pericoronarite aguda (dor, edema, trismo, linfadenite)**	SIM	Amoxicilina 500 mg + metronidazol 250 mg, ambos VO, a cada 8 h	Clindamicina 300 mg, a cada 6 h e metronidazol 250 mg, a cada 8 h também em imunossuprimidos [1]	Prescrever 3 dias; reavaliar após 72 h. Pode ser mantido por 7 dias.	Nos casos de pericoronarite recorrente, o tratamento definitivo é a exodontia do dente associado. Iniciar o antibiótico e agendar a cirurgia quando houver remissão da fase aguda.
 **Alveolite (osteíte alveolar)**	NÃO	Uso antisséptico ou técnica cirúrgica com nova curetagem. Cefalexina para casos selecionados: 1–2 g VO, 2x/dia ou amoxicilina 500 mg, 3x/dia (3–5 dias) [1]	Clindamicina ou azitromicina em casos selecionados: 300 mg, 1x/dia (3 dias) ou 1 g, 1x/dia (3 dias) [1]	3–5 dias, se indicado	Dor, halitose e exposição óssea podem ocorrer na ausência de infecção ativa. O antibiótico deve ser reservado para casos selecionados com sinais sistêmicos ou infecção secundária.



* Não usar cefalosporina se houver **anafilaxia, angioedema** ou urticária com penicilina.



Em paciente saudável, a maioria das exodontias dispensa antibioticoterapia.

IMPORTANTE! | Nunca opere terceiro molar em pericoronarite aguda: trate a infecção, aguarde a remissão e agende a cirurgia ainda sob antibiótico.

8 INFECÇÕES ODONTOLÓGICAS

Drenagem: foco cirúrgico vs. terapêutico

O antibiótico complementa a drenagem. O critério para prescrever são os sinais de disseminação:

PROCEDIMENTO / QUADRO CLÍNICO	NECESSITA ANTIBIÓTICO?	1ª ESCOLHA (DOSE/POSOLOGIA)	ALTERNATIVA PARA ALÉRGICOS	DURAÇÃO DO TRATAMENTO	OBSERVAÇÕES CLÍNICAS
 **Abscesso apical agudo**	NÃO	Foco cirúrgico: drenagem por via do canal ou incisão (dentina 1/3, nº 15, com solução com ação hemostática, irrigação com soro e drenagem com hemostático. Resolução da causa (endodontia, p. ex.).	—	—	Após drenagem, a área fica igual à de palpação em abscesso periapical localizado. Manutenção de dente em 24–72 h. Escoamento de canais de 90% e fossa 90%.
 **Abscesso com sinais de disseminação**	SIM Antecipar a drenagem	Amoxicilina 1 g VO (ataque), 30 min antes da drenagem; seguida de 500 mg, 8/8 h [1]	Clindamicina 300 mg (ataque) + 300 mg a cada 12 h	Prescrever 3 dias; reavaliar antes de suspender. Min. de 5–7 dias	Sinais: edema/celulite, trismo, linfadenite, febre, mal-estar. Depende de avaliar e instituir o controle da causa, manter o esquema quando os sinais melhorarem
 **Abscesso com disseminação em fase avançada**	SIM Antecipar a drenagem	Amoxicilina 1 g + metronidazol 250 mg (ataque) + amoxicilina 500 mg + metronidazol 250 mg a cada 8 h [1]	Clindamicina 600 mg (ataque) + 300 mg a cada 8 h ou clindamicina 300 mg a cada 12 h	3 dias + reavaliação; em geral 3–5 dias	Em infecções mais avançadas e não controladas, aumentar a clindamicina de 8 para 6 h
 **Abscesso localizado**	AVALIAR Individualizar conduta	Como as duas linhas acima, conforme a fase	Como as duas linhas acima	3–5 dias, com reavaliaçõe s diárias	Podem precisar de antibióticos mesmo com abscessos localizados. Individualizar conforme comorbidades.

INFECÇÕES ODONTOLÓGICAS (CONT.)

PROCEDIMENTO / QUADRO CLÍNICO	NECESSITA ANTIBIÓTICO?	1ª ESCOLHA (DOSE/POSOLOGIA)	ALTERNATIVA PARA ALÉRGICOS	DURAÇÃO DO TRATAMENTO	OBSERVAÇÕES CLÍNICAS
 **Infecção grave em espaços profundos**	**SIM** Hospitalar	Empírica IV de beta-lactâmico IV + sulbactam IV (ataque em casos selecionados, como pacientes imunodeprimidos: 3 g IV a cada 6 h [1])	Clindamicina 600–900 mg IV a cada 8 h [1]	Definida no hospital	Encaminhamento imediato. Avaliação por equipe de BMF. Controle da via aérea quando necessário. Ajustar conforme cultura e evolução.

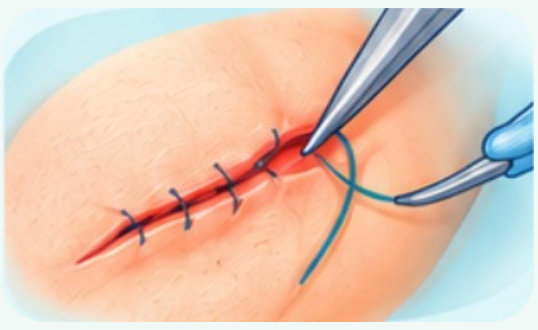
Abscesso localizado, sem sinais de disseminação, em paciente imunocompetente, resolve com drenagem e remoção da causa.

IMPORTANTE! | Trismo, disfagia, dispneia ou febre alta: encaminhe ao cirurgião bucomaxilofacial e ao hospital.

9 TRAUMA DE TECIDO MOLE

Lacerações, ferimentos corto-contusos e mordeduras

1 LACERAÇÃO OU FERIMENTO CORTO-CONTUSO LIMPO, RECENTE, SEM PERDA DE TECIDO



NÃO

Antibiótico não necessário.

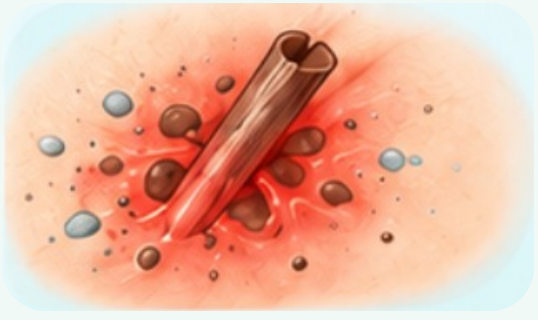
Conduta

Irrigação abundante com soro.
Desbridamento conservador.
Hemostasia.
Sutura por planos.

Observações clínicas

Avaliar necessidade de analgesia e cuidados locais.

2 FERIDA CONTAMINADA (CORPO ESTRANHO, ESMAGAMENTO, TECIDO DESVITALIZADO, TRANSPLANTE MUCOSA-PELE, ATENDIMENTO TARDIO OU PACIENTE DE RISCO)



AVALIAR

Amoxicilina 500 mg VO a cada 8 h ou Amoxicilina + clavulanato 875/125 mg VO a cada 12 h (se muito contaminada).

Alternativa para alérgicos

Clindamicina 300 mg VO a cada 8 h.

Duração do tratamento

3–5 dias, até 7 dias se contaminação grosseira.

Observações clínicas

Limpeza e desbridamento pesam mais que o antibiótico. Suspender se não houver evolução.

ANTIBIÓTICOS

3 MORDEDURA HUMANA OU ANIMAL EM FACE OU LÁBIO



SIM

Amoxicilina + clavulanato 875/125 mg VO a cada 12 h.

Alternativa para alérgicos

Clindamicina 300–450 mg a cada 6–8 h + sulfametoxazol + trimetoprima 800/160 mg a cada 12 h (em adultos).

Duração do tratamento

3–5 dias, como profilaxia; mais se infecção instalada.

Atenção

Avaliar raiva e tétano.

4 PROFILAXIA ANTITETÂNICA (INDEPENDENTE DO ANTIBIÓTICO)



AVALIAR

Verificar esquema vacinal.

Ferida limpa superficial

Vacinar se esquema incompleto ou última dose há 10 anos ou mais.

Ferida suja / grave

Vacinar se 3 doses ou esquema desconhecido, e considerar imunoglobulina antitetânica conforme protocolo.

Limpeza, desbridamento e sutura precoce previnem mais infecção que o antibiótico.

IMPORTANTE! | Avalie sempre a proteção antitetânica, mesmo quando o antibiótico não é indicado.

10 DOSAGENS HABITUAIS DE ANTIBIOTICOTERAPIA

Doses de manutenção para adultos

ANTIBIÓTICO	DOSE DE MANUTENÇÃO / INTERVALO USUAL
 Amoxicilina	500 mg a cada 8 h ou 875 mg a cada 12 h
 Metronidazol	250 mg ou 400 mg a cada 8 h ou 12 h
 Amoxicilina + clavulanato	500 mg + 125 mg a cada 8 h
 Cefalexina	500 mg a cada 6 h
 Claritromicina	500 mg a cada 12 h
 Azitromicina	500 mg a cada 24 h
 Clindamicina	300 mg a cada 8 h

ANTIBIÓTICOS

ATENÇÃO À CLINDAMICINA

A clindamicina apresenta maior risco de eventos adversos, incluindo distúrbios gastrointestinais, com diarreia, que pode estar associada ao Clostridioides difficile, podendo evoluir para colite pseudomembranosa, uma complicação potencialmente grave.

Seu uso deve ser reservado a situações em que haja indicação clínica.



METRONIDAZOL + ÁLCOOL

O metronidazol pode causar uma reação tipo dissulfiram quando associado ao álcool (etanol), com sintomas como náuseas, vômitos, cefaleia, rubor e cólicas abdominais. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante o tratamento.



11 SEQUÊNCIA DE DECISÃO CLÍNICA: USO DE ANTIBIÓTICOS

1 DIAGNÓSTICO
- Coleta de dados
- Avaliação clínica
- Exames (quando necessários)

2 INDICAÇÕES
- Condições de risco
- Critérios para profilaxia
- Comorbidades

3 ESCOLHA DO FÁRMACO
- História de alergia
- Farmacologia da droga
- Espectro (conforme agente suspeito)

4 POSOLOGIA
- Dose correta
- Intervalo
- Adequação à função renal/hepática

5 DURAÇÃO
- Tempo mínimo e eficaz
- Risco de resistência
- Reavaliação do paciente

6 VIA
- Oral na maioria dos casos
- Parenteral em situações específicas

7 MONITORAÇÃO
- Sinais de resposta clínica
- Efeitos adversos
- Ajustes de acordo com a evolução

8 REAVALIAÇÃO
- Tempo de resposta
- Necessidade de manter o tratamento

SEDAÇÃO MÍNIMA EM CTBMF

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O controle da ansiedade é parte essencial do planejamento cirúrgico. A ansiedade aumenta a liberação de catecolaminas endógenas, eleva a pressão arterial e a frequência cardíaca, reduz o limiar de dor e dificulta a colaboração do paciente — efeitos indesejáveis em hipertensos, cardiopatas e em procedimentos invasivos.[1,2]



MENSAGEM PRINCIPAL: A tranquilização verbal deve ser **SEMPRE** utilizada, associada ou não a ansiolíticos, em protocolo de sedação mínima. O fármaco complementa — não substitui — o manejo comportamental, a anestesia local eficaz e a comunicação assertiva.[1]

2 SEDAÇÃO MÍNIMA E SEGURANÇA (DIRETRIZES ADA 2025/2026)

Nível minimamente deprimido de consciência, produzido por método farmacológico, que preserva a resposta normal do paciente ao comando verbal. As funções ventilatória e cardiovascular permanecem inalteradas.[3]

Regra da Dose Máxima Recomendada (DMR): a administração enteral acima da DMR passa a ser considerada **sedação moderada,** exigindo treinamento **e monitorização específicos.**

Não repetir doses sem avaliar plenamente o efeito da anterior.[3]

REQUISITOS MÍNIMOS (CONSULTÓRIO)



Avaliação pré-operatória: anamnese, ASA, medicamentos em uso, PA, FC e SpO2.



Oximetria de pulso: monitorização contínua na sessão.



Oxigênio disponível: com ventilação com pressão positiva.



Equipe: ao menos um auxiliar treinado em SBV.



Acompanhante adulto e orientações por escrito.[3]

INDICAÇÕES CLÍNICAS



Ansiedade aguda não controlável por métodos não farmacológicos.



Cardiopatas, asmáticos ou epilépticos com doença controlada (para reduzir o estresse cirúrgico).



Intervenções invasivas/longas (dentes inclusos, implantes múltiplos, abscessos).



Recomenda-se comunicação prévia com o médico assistente.[1,11]

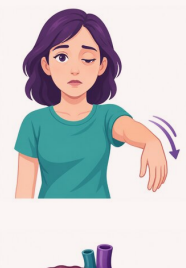
3 CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS


Hipersensibilidade.


Insuficiência respiratória grave.


Apneia do sono grave não tratada.


Miastenia grave.


Glaucoma de ângulo fechado não tratado.


Insuficiência hepática grave.


Intoxicação alcoólica aguda.


Uso de inibidores potentes do CYP3A4 (cetoconazol, itraconazol, ritonavir).


Crianças gravemente comprometidas (encaminhar ao ambiente hospitalar).[7,11]

PRECAUÇÕES (AVALIAR RISCO–BENEFÍCIO)


Gestantes (evitar, sobretudo no 1º trimestre e no final da gestação).


Idosos (Critérios de Beers 2023 — evitar sempre que possível).


Opioides (tramadol/codeína — risco de depressão respiratória e óbito, alerta da FDA).


DPOC e obesidade (risco de depressão respiratória).


Histórico de dependência química.[4,5,7,8]

4 BENZODIAZEPÍNICOS MAIS UTILIZADOS NA SEDAÇÃO MÍNIMA ORAL

FÁRMACO (APRESENTAÇÃO)	DOSE – ADULTOS	DOSE – IDOSOS*	DOSE – CRIANÇAS	TOMAR ANTES	PICO DE EFEITO	MEIA-VIDA (T½)
Midazolam Comp. 7,5/15 mg (Dormonid®)	7,5 – 15 mg	7,5 mg	0,25 – 0,5 mg/kg (sol. oral 2 mg/mL)	30 min	30 – 60 min	1,5 – 3 h (curta)
Diazepam Comp. 5/10 mg (Valium®)	5 – 10 mg	Evitar; se inevitável, 5 mg	0,25 – 0,5 mg/kg	60 min	60 – 90 min	20 – 50 h + metabólito ativo (longa)
Alprazolam Comp. 0,25/0,5/1 mg (Frontal®)	0,5 – 0,75 mg	0,25 mg	Não recomendado	45 – 60 min	1 – 2 h	11 – 15 h (intermediária)
Lorazepam Comp. 1/2 mg (Lorax®)	1 – 2 mg	0,5 – 1 mg	Não recomendado	2 h	~ 2 h	10 – 20 h (intermediária)

*Idosos: preferir midazolam ou lorazepam, na menor dose eficaz. Crianças: sem exceder a dose do adulto.[1,11,13]

5 CUIDADOS COM O PACIENTE QUE USA ANSIOLÍTICO

Orientações antes, durante e após o procedimento

ANTES DO PROCEDIMENTO



Vir acompanhado de um adulto responsável (que permaneça até a alta).



Não vir dirigindo carro, moto ou bicicleta.



Não ingerir bebida alcoólica nas 24 h anteriores.



Informar todos os medicamentos em uso, inclusive fitoterápicos (ex.: erva-de-São-João) e o consumo de suco de laranja.



Manter as medicações de uso contínuo (ex.: anti-hipertensivos), salvo orientação contrária.



Tomar o ansiolítico no consultório, no horário indicado; nunca tomar doses extras por conta própria.[10]

CUIDADOS COM O PACIENTE QUE USA ANSIOLÍTICO (CONT.)

APÓS O PROCEDIMENTO (PRÓXIMAS 24 H)



Ir para casa com o acompanhante; não usar transporte sozinho.



Não dirigir nem operar máquinas por 24 h (por mais tempo com diazepam e lorazepam, de efeito residual prolongado).



Não ingerir álcool nem outros sedativos ou opioides sem orientação.



Evitar decisões importantes e assinatura de documentos no mesmo dia.



Permanecer sob supervisão de um adulto nas primeiras horas; atenção ao risco de quedas, principalmente em idosos.



Crianças: no trajeto para casa, um adulto além do motorista deve observar a criança.



Ter por escrito o telefone de contato do profissional.[10]

PACIENTE EM USO CONTÍNUO DE BENZODIAZEPÍNICO



- Não suspender o medicamento antes da cirurgia: a interrupção abrupta pode causar abstinência e convulsões.
- Pode haver tolerância ao efeito ansiolítico: não aumentar a dose por conta própria; priorizar o manejo não farmacológico e conversar com o médico assistente.
- Somar outras doses de ansiolítico, opioide ou álcool aumenta a depressão do SNC.[1,11]
- O flumazenil deve ser evitado, pois pode precipitar abstinência e convulsões.[4,6,11]

6 CONDUTA EM CASO DE DOSE EXCESSIVA (SEDAÇÃO ALÉM DA PRETENDIDA)

! SINAIS DE ALERTA



Sonolência profunda; não responde normalmente ao comando verbal (sai da sedação mínima).



Fala arrastada, incoerente, relaxamento da mandíbula com roncos (obstrução).



Respiração lenta ou superficial: queda da SpO2 em relação ao basal (< 94%; grave < 90%).



Hipotensão, bradicardia.



Reação paradoxal: agitação, confusão, agressividade (mais comum em crianças e idosos).[2,3]

CONDUTA PASSO A PASSO

1. 

   Interromper o procedimento; remover gazes e rolos de algodão da boca e aspirar secreções.

2. 

   Estimular o paciente (chamar pelo nome, estímulo tátil). Se hipotenso, posição supina com elevação dos membros inferiores.

3. 

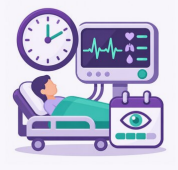
   Via aérea e oxigênio: elevação do mento / anteriorização da mandíbula; O2 suplementar, monitorizar SpO2, PA, FC e FR a cada 5 min.

4. 

   Hipoventilação ou apneia: ventilação com bolsa-válvula-máscara com O2 e acionar o SAMU 192, se necessário.

5. 

   Flumazenil (Lanexat®): 0,1 mg/mL; requer acesso venoso e profissional habilitado; 0,2 mg IV em 15 s, se não houver resposta em 60 s, 0,1 mg a cada 60 s até o máximo de 1 mg (dose usual total 0,3–0,6 mg).

6. 

   Observar a ressedação: a meia-vida do flumazenil é menor que a dos benzodiazepínicos; manter em observação por pelo menos 2 h após a última dose ou encaminhar ao serviço de urgência.[2,11]

7. 

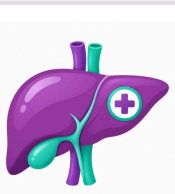
   Reação paradoxal: interromper, manter ambiente calmo, proteger de quedas e traumas, monitorar e não repetir a dose do ansiolítico.[2,11]

ANSIOLÍTICOS

7 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS RELEVANTES

- **Opioides (tramadol/codeína):** risco de depressão respiratória.
- **Inibidores do CYP3A4** (azólicos/macrolídeos): ↑ níveis de midazolam e alprazolam.
- **Álcool e outros depressores do SNC:** potencialização da depressão do SNC.
- **Indutores (carbamazepina, fenitoína,** rifampicina, erva-de-São-João): reduzem o efeito.[3,8]

8 POPULAÇÕES ESPECIAIS

POPULAÇÃO	ORIENTAÇÃO
 **Idosos** (Beers 2023)	potencialmente inadequados; aumentam o risco de quedas, fraturas e delirium. Se indispensável: dose única, menor dose.
 **Gestantes**	evitar, sobretudo no 1º trimestre e no final da gestação.
 **Crianças** (AAP/AAPD)	nunca administrar em casa; somente no consultório, sob supervisão.
 **Hepatopatas**	preferir lorazepam (glucuronidação direta); contraindicado na insuficiência hepática grave.[4,5,7,8]

9 ALTA E ORIENTAÇÕES FINAIS



Apenas quando acordado e orientado, com sinais vitais próximos ao basal.



Registrar no prontuário o evento, doses e horários.



Fornecer orientações por escrito ao paciente e ao acompanhante.



Flumazenil é contraindicado em usuários crônicos de benzodiazepínicos.[4,5,6,8]



Benzodiazepínicos são psicotrópicos da Lista B1 (Portaria SVS/MS nº 344/1998) e só podem ser prescritos com Notificação de Receita B (azul).[2,7,10]

REFERÊNCIAS

ANALGÉSICOS

1. Carrasco-Labra A, Polk DE, Urquhart O, Aghaloo T, Claytor Jr JW, Dhar V, Dionne RA, Espinoza L, Gordon SM, Hersh EV, Law AS. Evidence-based clinical practice guideline for the pharmacologic management of acute dental pain in children: A report from the American Dental Association Science and Research Institute, the University of Pittsburgh School of Dental Medicine, and the Center for Integrative Global Oral Health at the University of Pennsylvania. The Journal of the American Dental Association. 2023 Sep 1;154(9):814-25.
2. Khan AA, Diogenes A. Pharmacological management of acute endodontic pain. Drugs. 2021 Sep;81(14):1627-43.
3. Miroshnychenko A, Ibrahim S, Azab M, Roldan Y, Martinez JP, Tamilselvan D, He L, Little JW, Urquhart O, Tampi M, Polk DE. Acute postoperative pain due to dental extraction in the adult population: a systematic review and network meta-analysis. Journal of Dental Research. 2023 Apr;102(4):391-401.

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS

1. MATEUS, Moysés Matias et al. Controle farmacológico de complicações em cirurgia de terceiros molares por meio da utilização de anti-inflamatórios não esteroidais combinados ou isolados a opioides. Research, Society and Development, v. 11, n. 6, e3311628807, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i6.28807.
2. SANTOS, B. F. E.; COSTA, F. O.; PINTO JÚNIOR, A. A. C.; ARAÚJO, A. V. A.; CYRINO, R. M.; COTA, L. O. M. Postoperative pain and edema control following different protocols of preemptive analgesia in the surgical removal of impacted third molars: a triple-blind parallel randomized placebo-controlled clinical trial. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, v. 49, n. 8, p. 694-704, 2021. DOI: 10.1016/j.jcms.2021.01.002.
3. SINHA, V. R.; KUMAR, R. V.; SINGH, G. Ketorolac tromethamine formulations: an overview. Expert Opinion on Drug Delivery, v. 6, n. 9, p. 961-975, 2009. DOI: 10.1517/17425240903116006.
4. SOARES, Josivaldo Bezerra et al. Uso sistêmico de analgésicos e anti-inflamatórios na odontologia: uma revisão integrativa da literatura. RFO UPF, Passo Fundo, v. 30, n. 1, 2025.

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS

1. Almeida RAC, Lemos CA, de Moraes SLD, Pellizzer EP, Vasconcelos BC. Efficacy of corticosteroids versus placebo in impacted third molar surgery: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Oral Maxillofac Surg. 2019;48(1):118–131. doi:10.1016/j.ijom.2018.05.023.
2. Canellas JVS, Ritto FG, Tiwana P. Comparative efficacy and safety of different corticosteroids to reduce inflammatory complications after mandibular third molar surgery: a systematic review and network meta-analysis. Br J Oral Maxillofac Surg. 2022;60(8):1035–1043. doi:10.1016/j.bjoms.2022.05.003.
3. Miroshnychenko A, et al. Corticosteroids for managing acute pain subsequent to surgical extraction of mandibular third molars: a systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2023;154(8):727–741.e10. doi:10.1016/j.adaj.2023.04.018.

REFERÊNCIAS

ANTIBIÓTICOS

1. Andrade ED. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3ª ed. Artes Médicas.
2. Orire I, Sagoe M, Muzny CA, Kissinger PJ. Revisiting the Disulfiram-Like Reaction Between Alcohol and Oral Metronidazole. Sex Transm Dis. 2026;53(4):205-208. doi:10.1097/OLQ.0000000000002276.
3. Schmid AI, Werkmeister R, Al-Nawas B, Heider J. Antibiotic resistance in odontogenic infections: A systematic review of current evidence and implications for guideline-based therapy. Clin Oral Investig. 2026;30(5):183. doi:10.1007/s00784-026-06848-1.
4. Momma P, Nairni-Akbar A, Hultin M, Lund B, Götrick B. Is routine antibiotic prophylaxis warranted in dental implant surgery to prevent early implant failure? - a systematic review. BMC Oral Health. 2024;24(1):842. doi:10.1186/s12903-024-04611-0.
5. Andrade ED. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3. ed. São Paulo: Artes Médicas; 2014.
6. Mullen MT, Urvater MK, Hillis E, Velide S, Mudiganty S, Godshaw BM. Antibiotic Prophylaxis for Dental Procedures Following Total Joint Arthroplasty: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Arthroplasty. 2026;41(5):1590-1596. doi:10.1016/j.arth.2025.08.079. PMID:40935425.
7. Cuevas-Gonzalez MV, Cuevas-Gonzalez JC, Espinosa-Cristóbal LF, et al. Use or abuse of antibiotics as prophylactic therapy in oral surgery: A systematic review. Medicine (Baltimore). 2023;102(37):e35011. doi:10.1097/MD.0000000000035011. PMID:37713865.
8. Ajiji P, Uzunali A, Ripoche E, et al. Investigating the efficacy and safety of metronidazole during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X. 2021;11:100128. doi:10.1016/j.eurox.2021.100128. PMID:34136799.

ANSIOLÍTICOS

1. Andrade ED. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 3. ed. Artes Médicas; 2014.
2. Malamed SF. Sedation: a guide to patient management. 7th ed. Elsevier; 2025.
3. American Dental Association. Guidelines for the use of sedation and general anesthesia by dentists. Chicago: ADA; 2025.
4. FDA. Drug Safety Communication: opioids and benzodiazepines. 2016.
5. FDA. Boxed Warning updated for benzodiazepine drug class. 2020.
6. Coté CJ, Wilson S; AAP/AAPD. Guidelines for monitoring and management of pediatric patients before, during, and after sedation. Pediatrics. 2019;143(6):e20191000.
7. 2023 AGS Beers Criteria® Update Expert Panel. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-81.
8. Wu H, et al. The safety of benzodiazepines and related drugs during pregnancy: meta-analysis. Arch Gynecol Obstet. 2024;310(1):45-54.
9. Brasil. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.
10. Brasil. Anvisa. RDC nº 1.000, de 11 de dezembro de 2025.
11. Peter J, et al. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and side effects of midazolam. Pharmaceuticals. 2024;17(4):473.
12. Flumazenil (Lanexat®): bula para o profissional. Anvisa.
13. Brunton LL, Knollmann BC. Goodman & Gilman's. 14th ed. McGraw Hill; 2023.

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCOMAXILOFACIAIS
FOUSP